

32 - FMPP MOOCs - Les abcès hépatiques - Pr. Rabbani

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule « Les abcès hépatiques ». Comme objectif d'apprentissage, on doit connaître les principaux facteurs étiopathogéniques des abcès hépatiques, connaître aussi les principaux tableaux cliniques de l'abcès hépatique, connaître les différentes étiologies de ces abcès hépatiques et connaître les principes du traitement de ces abcès du foie. Comme prérequis, vous devez savoir connaître l'anatomie du foie et la séméiologie de l'abcès hépatique. Pour cela, on va adopter le plan suivant.

On va commencer par un rappel anatomique qui est important, la définition de l'abcès hépatique, l'épidémiologie, une physiopathologie pour comprendre le mécanisme et les germes responsables, l'anatomopathologie pour connaître aussi les différentes lésions de ces abcès hépatiques, comment poser le diagnostic positif, savoir aussi poser les diagnostics étiologiques, connaître les complications et quels sont les diagnostics différentiels. Et après, on va voir les traitements de cette pathologie, les pronostics et après on va conclure. Alors, comme rappel anatomique, comme vous le savez, le foie, c'est un organe qui est intra-abdominal, central, qui assure plusieurs fonctions.

Parmi ces fonctions, il y a des fonctions de l'homéostasie de l'organisme. Il fait plusieurs synthèses, par exemple la synthèse des protéines, l'albumine par exemple. Il métabolise aussi le glucose.

Il permet la dégradation de plusieurs médicaments et aussi, il a un rôle d'excrétion. Par exemple, l'excrétion de la bilirubine qui va jouer un rôle très important dans la digestion. Les voies biliaires qui sont donc l'ensemble des conduits qui transportent la bile et qui sont sécrétées par le foie vers l'intestin ou la bile vers l'intestin ou la bile qui participe notamment à la digestion et à l'absorption des nutriments.

Alors, cet organe qui est la plus grande glande de l'organisme, il est vascularisé par une artère hépatique, par une veine porte et bien sûr, dans le pédicule hépatique, on trouve les voies biliaires. Alors cette veine porte qui est très importante, c'est elle qui va acheminer tout le son du tube digestif sous diaphragmatique vers le foie, c'est-à-dire le son qui vient de la région splénique et gastrique par la veine splénique. Le son qui vient du colon gauche, la moitié du colon transverse et le rectum via la veine mésentérique inférieure et bien sûr, la grande partie qui vient de l'intestin grêle, du duodéno pancréas, du colon droit et de la moitié droite du colon transverse qui va vers la veine porte à travers la veine mésentérique supérieure.

Alors, comme vous le voyez ici sur une reconstitution scanographique, on voit ici la constitution ou la formation de la veine porte qui est constituée par le transplénomésaraïque qui est formé par la veine mésentérique inférieure et par la veine splénique et bien sûr, avec la veine mésentérique supérieure. Alors comme définition, c'est quoi la définition d'un abcès hépatique? Ça se définit par une collection purulente qui résulte d'un processus infectieux qui va détruire le parenchyme

hépatique. C'est une pathologie qui reste peu fréquente et il est dû à plusieurs infections, notamment des infections biliaires ascendantes et parfois on ne connaît pas leur origine.

C'est ce qu'on appelle les abcès cryptogénétiques ou cryptogéniques, c'est-à-dire que ce sont des abcès d'origine indéterminée qui restent quand même fréquents. Les germes qui sont responsables de cet abcès, ils sont dominés par les bacilles gramme négatives dans presque 90% des cas, avec bien sûr les germes anaérobiques. Le diagnostic positif est posé le plus souvent par l'échographie et la TDM, surtout le scanner abdominal qui est l'outil diagnostique majeur par excellence pour cette pathologie.

Ils ont un rôle diagnostique et aussi un rôle thérapeutique puisque ça nous aide dans le traitement lors des ponctions drainage percutanée, couplée bien sûr à l'antibiothérapie. Le pronostic de cet abcès hépatique reste sombre car les complications locales et surtout les complications générales et systémiques sont graves et parfois ils sont conditionnés par l'état général du patient, notamment les facteurs de risque comme le diabète ou bien une immunosuppression. Concernant l'épidémiologie, comme on a dit, c'est une infection qui est rare.

Il touche un cas sur 10 000 hospitalisations. Son incidence est en augmentation puisqu'on commence à avoir des immunodéprimés dans nos hôpitaux à cause de l'immunodéficience acquise, VIH, à cause aussi des médicaments comme la corticothérapie. Le terrain prédispose en particulier.

On note aussi une prédominance masculine légère par rapport aux femmes, donc 57% d'hommes. L'âge moyen, c'est entre 50 et 60 ans. Les facteurs de risque, comme on a dit tout à l'heure, c'est surtout l'état comme le diabète sucré, l'alcoolisme chronique et l'existence d'une immunodépression.

Un mot sur la physiopathologie, les germes des abcès hépatiques peuvent venir de plusieurs régions. Ils peuvent venir soit de la bile, soit du sang, soit des organes de voisinage. De la bile, c'est l'origine biliaire.

Du sang, généralement, ils viennent par la veine porte, c'est-à-dire la veine qui va collecter tout le sang du tube digestif. Donc n'importe quelle infection au niveau du tube digestif sous diaphragmatique peut causer ou se compliquer par un abcès hépatique. Et par contiguïté aussi, c'est-à-dire lorsqu'il y a une perforation d'un organe de voisinage, dont le foie, ça peut provoquer un abcès hépatique, notamment d'origine vésiculaire, l'ongle colique droit, l'estomac et le duodénum, parce que ce sont des organes qui ont des rapports intimes avec le foie.

Concernant les portes d'entrée de l'abcès hépatique, on a dit que les causes biliaires sont les plus fréquentes. C'est entre 30 et 70 % des cas. Ça peut être soit d'origine maligne, comme des cancers de la vésicule biliaire ou des cancers des voies biliaires, ou bien bénigne, comme la pathologie lithiasique, des lithiases de la voie biliaire principale qui vont se compliquer par des ongles guécolites et qui vont aussi se compliquer par des microbes abcès hépatiques.

La pancréatite aussi peut se compliquer par un abcès hépatique. Les causes portales, c'est-à-dire sanguines qui vont venir des organes intra-abdominaux digestifs sous diaphragmatiques, ça peut être bénigne, comme les diverticulites, ou bien les maladies inflammatoires chroniques intestinales, les MICI, ou bien une perforation digestive, une appendicite, une salpingite ou un abcès pancréatique. D'origine maligne, c'est surtout des cancers, un cancer colique ou un cancer gastrique infecté, ça peut donner un abcès hépatique.

La troisième cause, c'est des causes artérielles, c'est ce qu'on appelle la septicémie. La porte d'entrée peut siéger dans n'importe quel organe dans l'organisme, que ça soit au niveau du cœur, que ça soit au niveau du système urogénital, dentaire, ORL, ou bien osseux. Les abcès par contiguïté, c'est les organes qui sont tout autour du foie.

Il y a aussi une autre cause, c'est l'abcès post-traumatique lors d'un traumatisme ouvert sur tout, ou fermé parfois de l'abdomen et du foie. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des causes qui sont indéterminées, c'est les abcès cryptogéniques qui représentent quand même un pourcentage de 10 à 40%. Les germes qu'on isole au niveau de cet abcès hépatique, ils sont dominés par les bactéries anaérobies à gramme négative, comme les *Chlamydia coli*, dont 39% des cas, ou bien l'éclésielle pneumonie.

On peut isoler aussi les bactéries anaérobies, les *Fusobacterium* et la *Bacteroides*, et le *Clostridium*. Aussi, on peut trouver des bactéries aérobies à gramme positive, comme les streptocoques ou bien les staphylocoques. On note que la fréquence des streptocoques du groupe D est de 36,5% des cas.

Comme on peut trouver un abcès polymicrobien, c'est-à-dire qu'on peut isoler plusieurs microbes, plusieurs bactéries, et des anaérobies, et des aérobies, et des BG positifs. Alors là, on voit un schéma qui va nous montrer ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, c'est l'origine biliaire.

Donc là, on isole quels sont les germes qui viennent de la bile. C'est beaucoup plus les *Chlamydia coli*. Pour la voie sanguine artérielle, les voies génitales urinaires, c'est beaucoup plus les *Fusobacterium*.

Pour les voies aériennes et orales, on peut isoler presque tous les germes, notamment les streptocoques. Et pour le collant, c'est les anaérobies et les bactéroïdes. Alors le terrain, c'est le plus souvent, il y a un facteur de risque.

Alors ces facteurs de risque, ils peuvent être d'ordre général ou local. On peut citer les maladies biliopancréatiques, l'éthylisme dans 15% des cas, le diabète dans 15% des cas, ou bien un antécédent d'une néoplasie digestive ou une chirurgie abdominale récente. Alors quel est le mécanisme de la survenue de ces abcès ? Les abcès apyogènes sont une infection qui est sévère et qui peut entraîner des complications qui sont parfois graves.

Alors il y a deux types de complications, les manifestations ou les complications locales. Ce sont des phénomènes inflammatoires qui sont liés au sepsis hépatique et qui peuvent entraîner parfois des thromboses au niveau du système porte et parfois au niveau du système de veine sushépatique. Alors plus rarement, de volumineuses abcès peuvent se remplir soit dans le péritoine en provoquant une péritonite, soit bien sûr aplogènes, soit dans les structures de voisinage.

On peut avoir donc soit une perforation au niveau de la plèvre en provoquant une pleurise. Les complications d'ordre général, c'est surtout les chocs septiques qui sont dus à des métastases septiques par voie artérielle qui peuvent se compliquer par une défaillance multiviscérale qui peuvent engendrer le pronostic vital. Alors quels sont les types de lésions qu'on peut trouver lors d'un abcès hépatique ? Les lésions peuvent être soit uniques, soit multiples.

Unique, c'est le plus souvent au niveau du foie droit, mais on peut trouver de lésions multiples au niveau des deux lobes, droit et gauche du foie. Ça se forme sur des cavités néoformées qui sont créées par la nécrose du parenchyme hépatique, et ainsi de suite, ou bien greffées sur une cavité qui est préexistante, soit des kystes hydatiques qui sont surinfectées, ou bien une cavité d'un kyste hydatique déjà traité chirurgicalement qui a laissé une cavité résiduelle et cette cavité va se surinfecter. Les localisations peuvent être soit superficielles, c'est-à-dire sous-capsulaire ou au niveau de la surface du foie, soit ça peut être périhépatique, c'est-à-dire à côté des organes de voisinage, ou bien profonde, ils sont enchâssés au niveau du parenchyme hépatique.

Et comme on a dit tout à l'heure, le lobe droit contient plus des deux tiers des cas des abcès hépatiques. Passons au diagnostic positif. Cliniquement, quels sont les signes fonctionnels pour lesquels le patient va consulter ? Le premier signe alarmant, c'est la fièvre élevée.

Je parle d'une fièvre très élevée, c'est-à-dire une fièvre qui est au-delà de 39, 39,5, voire même les 40, 41, avec des frissons, qui est un signe important de la septicémie. Les douleurs abdominales, elles sont existantes dans 73% des cas. Ces douleurs sont de sièges épigastriques ou bien au niveau de l'hypocondre droit.

Elles peuvent être généralisées lorsque l'abcès est rompu. On peut avoir aussi des signes d'irritation péritoniale, notamment les vomissements ou nausées dans 30% des cas. On peut noter aussi une altération de l'état général avec une asthénie, une anorexie et une perte de poids.

Parfois, on peut avoir des signes respiratoires lorsque l'abcès est perforé au niveau de la plèvre ou bien lorsque l'abcès siège au niveau du dôme hépatique et comprime l'air pulmonaire. Des sueurs, surtout nocturnes. Il faut toujours chercher dans l'interrogatoire si le patient a eu une diarrhée récente avant l'apparition de ces signes cliniques pour éliminer une étiologie amibienne.

Quand on va examiner notre patient, on va commencer toujours par l'inspection. On va trouver que c'est un patient qui est subhétérique. A la palpation, c'est une hépatomégalie qui est très douloureuse.

Le signe le plus important, c'est la douleur à l'ébranlement du foie. Quand on va frapper le foie par un coup de poing, le patient va manifester une douleur très importante. Parfois, on peut avoir même un tableau pseudo-chirurgical.

Ça veut dire que ça ressemble à une péritonite lorsqu'il y a une perforation de cet abcès au niveau de tout l'abdomen ou bien une défense franche de l'hypochondre droit. Récapitulons, ce tableau n'est complet que dans la moitié des cas. Il ne faut pas s'attendre à un tableau qui est typique à 100%.

La fièvre, c'est un élément qui est quasi constant. Il doit attirer l'attention chez un patient qui est immunodéprimé avec des douleurs de l'hypochondre droit. Il doit être constaté dans plus de 90% des cas.

C'est la triade de Fontaine. C'est l'hépatomégalie douloureuse et fébrile qui doit attirer l'attention vers le diagnostic d'un abcès hépatique. Une fois le diagnostic est suspecté, on va demander des examens complémentaires.

On va commencer par le bilan biologique, tout en sachant que les anomalies biologiques lors de l'abcès hépatique sont très peu spécifiques et qui vont refléter un sepsis ou un syndrome inflammatoire avec une augmentation de plusieurs marqueurs au niveau du sang, notamment une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile lorsqu'il s'agit d'un abcès apyogène. Ce sont des globules blancs qui sont supérieurs à 10 000. Une CRP qui est très élevée.

Une anémie qui reste une anémie inflammatoire normochrome normocytaire avec une hyperplaquétose qui est supérieure à 500 000 ou bien parfois une thrombopénie lorsqu'il y a un choc. Le taux de fibrinogène qui est augmenté et bien sûr la procalcitonine qui est un marqueur d'inflammation qui va être élevé et qui est généralement élevé lors des infections bactériennes. On va noter aussi une perturbation du bilan hépatique et une hypoalbuminémie qui peut être expliquée par la diminution de synthèse hépatique de l'albumine et qui va être inférieure à 37 g par litre.

Le bilan radiologique, l'ASP ou l'abdomen sans préparation n'a pas beaucoup d'intérêt pour le diagnostic de l'abcès hépatique. Son intérêt est limité lorsqu'il y a un abcès hépatique à localisation au niveau du dôme hépatique ou bien lorsqu'il est rompu au niveau de la plèvre et ça peut donner un épanchement pleural droit. Donc vous voyez ici on peut avoir une ascension de la coupole diaphragmatique droite comme on peut avoir un niveau hydro-aérique de l'hypocondre droit mais c'est très rare.

Alors l'examen le plus important c'est l'échographie hépatobiliaire et c'est l'examen de première

intention. C'est un examen qui a trois buts. Donc un but de diagnostic positif, un but de diagnostic étiologique et aussi un but thérapeutique.

Alors on va commencer par le diagnostic positif. L'échographie c'est l'examen de choix. C'est un examen qui est anodin, qui est sans risque pour le patient.

On peut le répéter plusieurs fois. Malheureusement c'est un examen qui a l'inconvénient d'être opérateur dépendant. Il va montrer une image caractéristique si l'abcès du foie est collecté.

Alors à la phase collectée il y a une image qui est spécifique qu'on va voir tout à l'heure. Alors l'image est variable selon le stade évolutif de l'abcès que ce soit présupératif ou supératif. Alors lors de la phase présupérative les lésions hétérogènes sont de contours irréguliers et on n'arrive pas vraiment à avoir un diagnostic qui est certain.

Alors dans la phase supérative le contenu est hippo ou bien anécogène, c'est à dire noirâtre. Parfois qui est multiloculé ou bien simple avec des contours qui sont arrondis à paroi nette avec une coque épaisse. C'est la membrane ou la paroi du kyste.

Alors le deuxième rôle de l'échographie c'est de détecter ou de diagnostiquer l'étiologie, c'est à dire c'est quoi la cause de cet abcès. Que ce soit une cause biliaire, une cholecystite aiguë ou bien une cause digestive comme les appendicites aiguës ou une cause diverticulaire par une perforation d'un diverticule colique ou bien un cancer abcédé colique. Le troisième rôle au but de l'échographie c'est dans un but thérapeutique.

Il permet la ponction et le drainage. On va le voir tout à l'heure lors du chapitre traitement. Alors l'examen qui reste le gold standard dans le diagnostic des abcès du foie c'est le scanner abdominal.

Bien sûr avec injection de produits de contraste et sur le temps artériel et sur le temps portal. C'est un examen qui est systématique. Il permet de préciser la taille de l'abcès hépatique, son siège, le nombre des abcès hépatiques qui vont déterminer le pronostic et bien sûr le rapport avec les différents éléments anatomiques.

Notamment les éléments intrahépatiques comme les voies biliaires, les vensus hépatiques et les éléments extrahépatiques comme la plèvre, le colon, l'ongle colique droit et le duodenum. Alors lors de la phase présupérative, on a des lésions qui sont hypodenses et avasculaires pouvant mimer parfois une tumeur. Donc on n'arrive pas à différencier entre un abcès et une tumeur.

Alors lors de la phase supérative où les lésions sont un petit peu claires, l'aspect hétérogène est multicloisonné, mal limité avec un aspect qui est toujours hypodense et mal limité. Parfois on peut trouver des rayossemements périphériques au temps artériel et un aspect en cible, c'est-à-dire un centre qui est hypodense et une périphérie qui est épaissie et rayossée, c'est la membrane ou la paroi de l'abcès. L'aspect le plus caractéristique, c'est l'aspect en double cible, c'est un centre

qui est hypodense avec une périphérie qui est épaissie et rayossée, puis un autre halo du foie sain qui représente l'inflammation périlésionnelle au contact de cet abcès hépatique.

Alors toujours dans le scanner abdominal, la présence d'air caractérise les abcès hapiogènes, mais généralement il n'est retrouvé qu'une fois sur cinq. Il y a un autre examen, c'est l'imagerie par résonance magnétique, mais qui n'est pas plus performante que le couple échographie scanner, donc c'est un examen qu'on ne demande pas en première intention. On le réserve chez les patients, par exemple, qui ont une allergie à l'iode ou bien une suspicion d'abcès hépatique chez une femme enceinte chez qui on ne peut pas injecter ses ailes d'enclodes.

Donc l'abcès, les caractéristiques, c'est qu'il se présente en général en hyposignal en T1 et en hypersignal en T2. Alors cet abcès, il est suspecté par des examens radiologiques, par des examens biologiques, mais il est confirmé par une preuve bactériologique, comme les hémocultures qui vont donc nous montrer le type ou le germe responsable dans 42% des cas qui doit être répété à trois reprises, soit lorsque le patient présente des pics fébriles ou bien lorsque le patient présente des frissons. Alors la panxion, soit par voie scanoguidée comme on voit ici, donc là c'est un abcès hépatique et là c'est une aiguille pour faire la panxion.

Donc soit une panxion par voie scanoguidée ou bien par voie échoguidée. Le diagnostic se fait par une aiguille ou un scanner avec une aiguille qui est fine et bien sûr il faut mettre la mise en route d'une antibiotérapie en raison de risque de métastase sceptique favorisé par le geste. Quand on fait la panxion, il faut mettre le patient directement sous antibiotiques parce qu'il y a un risque de dissémination.

Il y a d'autres examens qu'il faut demander mais ce sont des examens pour éliminer, c'est-à-dire pour les autres diagnostics différentiels. Il faut demander une sérologie amébienne pour éliminer un abcès amébien et une sérologie aidatique pour éliminer un kyste aidatique. Alors une fois le diagnostic positif est là, on va passer au diagnostic idéologique pour chercher la cause.

Comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs causes mais généralement il y a trois causes d'abcès. C'est soit des abcès d'origine digestive, c'est des polypes, des cancers coliques, des appendicites, des maladies inflammatoires, c'est-à-dire tout le territoire du drainage de l'artère mésentérique inférieure et de l'artère mésentérique supérieure. Il y a des abcès qui sont d'origine biliaire, c'est soit secondaire à des lithiases vésiculaires ou bien une pathologie de la voie biliaire principale, notamment les cholangites, les cholangiocarcinomes, les maladies de Caroli.

Soit des abcès d'origine extra-digestive, c'est par voie artérielle comme on a dit tout à l'heure, donc soit d'origine dentaire, ORL ou gynécologique. Si aucune cause n'est mise en évidence, on parle d'abcès cryptogénétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause qui est déterminée. Concernant les complications de l'abcès hépatique, ils sont d'ordre loco-régional.

Ils peuvent provoquer parfois des thromboses de système porte ou bien des ventus hépatiques. Il peut se rompre au niveau de l'abdomen en provoquant une péritonite ou bien au niveau de la

plèvre en provoquant une pleurésie. Et il peut aussi causer un sepsi sévère, un choc septique, c'est d'ordre général.

Les diagnostics différentiels, il faut éliminer bien sûr les abcès hépatiques d'origine parasitaire, soit les datidoses, le kystidatigue du foie, soit les abcès amébiens, d'où il faut faire les deux sérologies. Les abcès fongiques aussi qui se voient chez les sujets immunodéprimés, les kysts biliaires compliqués sur infectés, les tumeurs, tout type de tumeur hépatique peut simuler un abcès hépatique. Les tumeurs pseudo-inflammatoires et les abcès froids, bien sûr, mais il y a une grande différence cliniquement entre les abcès froids et les abcès chauds.

Quand on parle d'abcès chauds, c'est l'abcès hépatique. Quand on parle d'abcès froids, c'est d'origine soit tuberculeux, soit d'origine champignon ou parasite. Mais là, la fièvre n'existe, il n'y a pas de fièvre dans ces deux tables.

Alors, on va passer au traitement. Le traitement de l'abcès hépatique comprend une prise en charge de l'abcès lui-même et aussi l'éradication de la porte d'entrée de cet abcès. C'est pour ça qu'il faut traiter un traitement symptomatique et un traitement étiologique.

Alors, pourquoi traiter bien sûr l'étiologie? C'est parce que déjà l'étiologie, c'est une pathologie ayant sa propre gravité et aussi pour éviter la récurrence. Parce que si on traite juste l'abcès et on ne traite pas sa cause, ça va récidiver par la suite. Alors, il y a plusieurs stratégies pour le traitement.

Il y a soit l'antibiotique seul, soit l'antibiotique avec un drainage radiologique, soit une chirurgie. Malgré que la chirurgie, c'est à dire, il se retrouve réduite un peu, sa place est réduite dans le traitement des abcès du foie. Mais il garde un rôle important, surtout dans le traitement de l'étiologie.

Alors, concernant l'antibiotérapie, c'est un traitement qui doit être systématique pour tout abcès. Il doit être entamé en urgence par voie parentérale pendant une à deux semaines et qui doit être prolongé par voie orale durant deux à quatre semaines. Donc, si on fait deux à quatre semaines plus les deux semaines, ça fait quatre à six semaines.

Donc, c'est le traitement de l'abcès hépatique, c'est un traitement à long cours, c'est six semaines. Les antibiotiques qu'on utilise, c'est beaucoup plus les céphalosporines troisième génération avec les nitroimidazolés et le flageol, plus ou moins des aminosides. Alors, si on a une allergie, il faut éviter les céphalosporines et les remplacer par les fluoroquinolones.

Est-ce qu'on peut utiliser l'antibiotérapie exclusive? Oui, on peut l'utiliser, surtout quand on a de multiples abcès d'origine en géopolitique. Bien sûr, associé à un traitement de, c'est à dire, soit un traitement endoscopique ou chirurgical pour libérer la voie biliaire principale ou bien chez des patients qui sont immunodéprimés. En plus du traitement antibiotique, on a le traitement radiologique.

C'est soit une aspiration à l'aiguille ou bien un drainage percutané continu. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'aspiration? Juste une aspiration par une aiguille, c'est à dire vider la collection lorsqu'on a une petite collection qui est inférieure à 5 centimètres et un abcès qui est simple, bien limité et unique. Alors, lorsque l'abcès est de grande taille ou bien multicloisonné ou multilobulé, il faut utiliser le drainage percutané qui dure, c'est à dire on va ponctionner et laisser un drain pendant un certain moment jusqu'à que le drain ne ramène plus rien.

Alors donc, un geste simple qui est peu invasif, bien sûr, réalisé sous anesthésie locale, après mise en place d'une antibiotérapie pour limiter aussi les métastases sceptiques et les décharges bactériennes. La chirurgie, jusqu'aux années 70, le drainage chirurgical était le seul traitement des abcès hépatiques, mais après les années 70, il y a le développement de la radiologie interventionnelle qui ont commencé à traiter les abcès hépatiques par des drainages et par des ponctions. C'est un traitement qui est non invasif, mais la chirurgie, il garde toujours ses indications lorsque il y a soit un échec au traitement radiologique ou bien pour traiter la maladie causale ou l'éthiologie.

On peut utiliser le traitement sélioscopique qui reste un moyen aussi qui est une chirurgie qui est moins invasive. Alors concernant toujours le traitement chirurgical, son but aussi, c'est de traiter la cause et traiter l'éthiologie. Par exemple, pour les origines biliaires, on peut faire une cholecystectomie laparoscopique, on peut faire des résections hépatiques lorsqu'il s'agit de cancers surinfectés, on peut extraire des calculs au niveau de la voie biliaire principale lorsqu'il s'agit d'une ongiocolite aiguë.

Et aussi pour les causes digestives, on peut faire soit des appendicectomies ou bien des résections oncoliques pour des cancers digestifs ou des résections pour une pathologie diverticulaire. Alors concernant le pronostic de l'absence hépatique, avant les années 2000, la mortalité était de 17 à 24% dans la plupart des séries publiées. Mais actuellement, le pronostic s'est amélioré avec le développement de la prise en charge surtout médicale et aussi radiologique.

Il y a quelques facteurs pronostiques qui vont intervenir. C'est le diabète sucré qui va augmenter la mortalité et la morbidité. Le nombre d'abcès, plus il y a une nette augmentation de la mortalité en cas d'abcès multiple.

Et le psypsie sévère ou les chocs sceptiques qui est un facteur indépendant de la mortalité. Alors en conclusion, l'abcès hépatique, c'est une affection qui est rare mais grave. Le scanner reste l'examen paraclinique de première attention qui permet le diagnostic positif, éthiologique et les complications.

Et aussi, il permet de traiter par les ponctions et par les drainages. L'antibiothérapie est systématique lors du traitement de tout abcès hépatique associé à des drainages. Bien sûr, il va y avoir une prise en charge multidisciplinaire entre radiologues et chirurgiens.

Et le pronostic dépend de la rapidité du diagnostic du traitement adapté. C'est un arbre décisionnel pour les abcès du foie. On commence par un examen clinique avec un interrogatoire.

Le scanner abdominal, l'échographie hépatobiliaire et la mise en évidence des germes lors des hémocultures ou bien des ponctions. Alors si la cause est biliaire, on va demander des examens complémentaires spécialisés dans les voies biliaires. Lorsque la cause est digestive, il faut demander une coloscopie.

Bien sûr, on la demande après avoir mis le patient sous antibiotiques et drainé le patient. Et après, on va chercher les causes par les abcès. On commence par une coloscopie avec parfois une intubation de la dernière once illéale.

Alors si on trouve que c'est un cancer qui est la cause de cet abcès, on doit passer à une chirurgie qui doit être différée du traitement de l'abcès. Si la coloscopie est négative, il faut aller chercher une cause extra-digestive par un examen ORL détaillé, un examen gynécologique et une échographie cardiaque pour chercher une cause cardiaque. Et c'est là qu'il faut mettre le patient sous antibiotiques.

Je vous remercie.